LE **CISSS** DES LAURENTIDES
complice de votre santé

DIRECTION SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES – SOUTIEN À DOMICILE (SAPA SAD)

GUIDE CLINIQUE

Rôle et responsabilités du professionnel en ergothérapie œuvrant au soutien à domicile

Juillet 2025

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Québec

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides
Québec

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Titre	**Guide clinique – Rôles et responsabilités de l'ergothérapeute œuvrant au soutien à domicile**	
En vigueur	2025-07-02	
Révision	Ne s'applique pas	
Validation	2025-06-18	Comité de direction SAPA-SAD
Diffusion	2025-07-02	Dépôt sur l'intranet du CISSS des Laurentides ou autre modalité de diffusion
Application et personnes concernées	Tous les intervenants œuvrant en Soutien à domicile	
Document(s) remplacé(s)	Ne s'applique pas	
Document(s) initiateur(s)	Ne s'applique pas	
Document(s) en découlant	▪ Annexe 1 : Tableau des documents en découlant	

Table des matières

1. Introduction 4
2. Domaine d'application 4
3. Objectifs 4
4. Demande de renseignements 5
5. Mécanisme de suivi et de révision 5
6. Rôles et responsabilités 6
   6.1. Responsabilités de l'ergothérapeute au SAD pour tout type de clientèle 6
   6.2. La pratique de l'ergothérapeute au soutien à domicile 7
   6.3. Les activités réservées aux ergothérapeutes et applicables dans leur travail au soutien à domicile 8
   6.4. Principaux motifs de référence en ergothérapie 9
   6.5. Enjeux fonctionnels et sécurité à domicile 10
   6.6. Interventions reliées aux plaies 13
   6.7. Interventions reliées aux soins palliatifs et fin de vie 14
   6.8. Interventions reliées à la dysphagie 15
   6.9. Barrières architecturales et programme d'adaptation du domicile (PAD) 16
   6.10. Programme d'aide à la mobilité (programme d'attribution des fauteuils roulants, ambulateurs, des triporteurs et des quadriporteurs) 18
   6.11. Partenariat avec l'usager et ses proches : auto-soins, participation active et responsabilité partagée 20
   6.12. Critères de fin d'intervention 21
   6.13. Tenue de dossier 22

Annexe 1 – Tableau des documents en découlant 24
Annexe 2 – Documents de référence 25

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique,
dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

1. Introduction

Face au vieillissement de la population et à une demande de services sans cesse croissante et toujours dans une optique populationnelle visant à améliorer l'accès aux services, il devenait essentiel pour le soutien à domicile de revoir ses activités cliniques en ergothérapie. Un comité régional, composé de professionnels en ergothérapie, de coordonnateurs cliniques et de gestionnaires, a donc été mis en place en mai 2021.

Les objectifs généraux du comité régional étaient d'adresser les normes et standards de pratique auxquels les professionnels de l'ergothérapie pourront se référer, quant à la prestation de services attendue de leur part pour les usagers éligibles au soutien à domicile (SAD).

2. Domaine d'application

La présente procédure s'applique à tous les intervenants œuvrant en Soutien à domicile, sans égard à leur titre d'emploi.

3. Objectifs

Le principal objectif de ce guide est de préciser les activités professionnelles des ergothérapeutes ainsi que les rôles associés à leur fonction dans un contexte d'intervention au SAD[1] afin :

- D'assurer la mise en place de pratiques cliniques et organisationnelles cohérentes permettant de soutenir l'autonomie décisionnelle et fonctionnelle de l'usager à domicile;
- D'harmoniser les pratiques : critères de priorisation, processus clinique, plan d'intervention dans le respect des différents outils exigés par l'ordre professionnel;
- De maintenir, dans la prestation de services, un niveau de qualité élevé par l'encadrement de l'intervention, par la pertinence entre les besoins de l'usager et les services offerts tout en assurant une rigueur et une cohérence de la pratique;
- De favoriser le partenariat de soins et services avec les usagers et leurs proches;
- De promouvoir une approche collaborative optimale;
- D'utiliser judicieusement les compétences professionnelles de chacun;
- De soutenir les intervenants dans leur pratique;
- D'assurer une équité dans l'offre de services.

Ce guide clinique vise, également, à favoriser une compréhension commune du rôle et des responsabilités des ergothérapeutes œuvrant au programme du SAD du CISSS des Laurentides. Il précise la démarche clinique et oriente les interventions à l'intérieur de balises reliées à l'offre de services. Il se veut également un guide de référence pour orienter les nouveaux intervenants lors de leur intégration au SAD[1].

[1] Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024

4. Demande de renseignements

Pour une interprétation du texte ou pour une demande de renseignements concernant le présent guide, veuillez communiquer avec :

Pamela Dann, chargée de projet
Direction programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Soutien à domicile (DSAPA-SAD)
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Courriel : pamela.dann.tdb@ssss.gouv.qc.ca

5. Mécanisme de suivi et de révision

La présente procédure pourra être révisée, en tout temps, selon les besoins.

Par défaut, la procédure sera révisée aux deux (2) ans à partir de la date d'entrée en vigueur.

6. Rôles et responsabilités

L'ergothérapeute au SAD joue un rôle clé dans l'accompagnement des personnes qui rencontrent des difficultés à accomplir leurs activités quotidiennes en raison de limitations physiques, cognitives, sociales, affectives ou psychologiques et pour qui le maintien à domicile pourrait être compromis. Son principal mandat est de permettre à l'usager de maintenir ou améliorer son autonomie à domicile et sécuriser son environnement afin de favoriser une meilleure qualité de vie.

6.1. Responsabilités de l'ergothérapeute au SAD pour tout type de clientèle

Démarche clinique[2] : évaluation et interventions	▪ Explique à l'usager le rôle et le mandat, obtient le consentement de l'usager ou son représentant et favorise une approche de partenariat en recherchant l'engagement et la collaboration en lui faisant signer, lorsqu'applicable, un contrat d'engagement (voir annexe1). ▪ Procède à une collecte de données évaluatives et à l'évaluation des habiletés fonctionnelles *(précisions à la suite de ce tableau)*. ▪ Évalue et analyse la répercussion des symptômes, des déficiences, des incapacités et des problématiques environnementales sur les habitudes de vie, la sécurité et l'autonomie de la personne. ▪ Élabore un plan d'intervention en partenariat avec l'usager[3] et les proches en fonction de ses objectifs et de l'offre de services du SAD. ▪ Informe également l'usager et ses proches des ressources et programmes existants pouvant répondre à ses besoins et à l'atteinte de ses objectifs. ▪ Établit les balises d'intervention avec l'usager en lien avec l'offre de services en vigueur (ces balises seront spécifiées dans la section 6 « Tableau des interventions réalisées en ergothérapie au SAD »). ▪ Met en œuvre les interventions en vue de développer, améliorer, restaurer ou maintenir les aptitudes nécessaires pour l'accomplissement des habitudes de vie et occupations pour une autonomie optimale. ▪ Intervient également en vue de diminuer les situations de handicap, adapter l'environnement et optimiser la participation sociale. ▪ Utilise différentes stratégies pour renforcer la participation active de l'usager. ▪ Réévalue et assure un suivi du plan d'intervention.
Prévention / Promotion de la santé	▪ Favorise un niveau fonctionnel optimal et un engagement dans les activités significatives pour l'usager. ▪ Promeut une meilleure qualité de vie de l'usager dans sa communauté, contribuant ainsi à son bien-être. ▪ Enseigne des stratégies d'économie d'énergie, des mesures de prévention de chutes, des stratégies de transfert et de déplacement pour l'usager et/ou ses proches, etc.

[2] Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024, page 28

[3] Voir section 6.7 : partenariat avec l'usager et ses proches

Enseignement / Formation / Consultation	▪ Organise des activités de formation et/ou fait l'enseignement des principes de transferts, mesures de remplacement, équipements spécialisés auprès de ses pairs, des auxiliaires aux services de santé et services sociaux (ASSS), des partenaires, des usagers et leurs proches. ▪ Constitue une personne-ressource pour l'équipe interdisciplinaire. ▪ Supervise des étudiants dans le contexte d'un stage lié au programme d'étude en ergothérapie.
Encadrement clinique	▪ Forme et soutient le personnel qui n'est pas ergothérapeute[4] dans l'application de certains protocoles, par exemple les ASSS pour déterminer le besoin d'équipements pour l'hygiène corporelle en situation simple dans la salle de bain.

Par habiletés fonctionnelles, on entend la manière dont une personne réalise ses habitudes de vie : soins personnels, nutrition, déplacement, responsabilités, vie communautaire, communication et relations interpersonnelles, loisirs, etc.

Elles sont évaluées en tenant compte des facteurs liés à :

- La personne : les capacités sensorielles, motrices, cognitives et l'état émotif;
- L'environnement physique et social (capacité des proches);
- L'occupation : occupations significatives et habitudes de vie

6.2. La pratique de l'ergothérapeute au soutien à domicile

L'intervention en ergothérapie s'appuie sur l'évaluation des incidences des limitations fonctionnelles de la personne et des obstacles environnementaux sur sa capacité à réaliser ses occupations. Elle se caractérise par l'analyse de l'interaction entre la personne, son environnement physique et humain et ses occupations, et ce, dans le but de favoriser son autonomie fonctionnelle et une qualité de vie satisfaisante, de faciliter son maintien dans son milieu de vie et son intégration dans la communauté.[5]

Par l'occupation sous toutes ses formes, l'ergothérapie optimise les possibilités d'action de la personne sur ses habitudes de vie. L'occupation étant au cœur de l'ergothérapie, elle en constitue à la fois l'objet d'expertise et le moyen thérapeutique.[6]

Le champ d'exercice[7] des ergothérapeutes se décline de la façon suivante :

- Évaluer les habiletés fonctionnelles ;
- Déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d'intervention ;
- Réaliser des interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal ;
- Développer, restaurer ou maintenir les aptitudes ;
- Compenser les incapacités ;

[4] OEQ, en ligne, Participation du personnel non-ergotherapeute a la prestation des services d'ergotherapie - Lignes directrices
[5] OEQ 6 OEQ, Référentiel de compétences lié à l'exercice de la profession d'ergothérapeute au Québec, Mars 2013, p.11 19675_Norme_OEQ.indd
[6] OEQ 6 OEQ, Référentiel de compétences lié à l'exercice de la profession d'ergothérapeute au Québec, Mars 2013, p.11 19675_Norme_OEQ.indd
[7] Code des professions, article 37 o C-26 - Code des professions (gouv.qc.ca).

- Diminuer les situations de handicap et adapter l'environnement dans le but de favoriser l'autonomie optimale de l'être humain en interaction avec son environnement.

Les ergothérapeutes sont également liés à leur code de déontologie[8] qui régit l'exercice de leur profession en faisant état des devoirs, obligations et responsabilités professionnelles.

Au SAD, les ergothérapeutes sont appelés à prodiguer des conseils relatifs à la fonction physique, à encourager les saines habitudes de vie, à recommander des activités appropriées à la condition de l'usager ou à suggérer des conditions environnementales favorisant sa sécurité, pour ne citer que ces exemples. Ainsi, **ce rôle actif d'information, de promotion de la santé et de prévention de la maladie et des accidents**, que jouent les ergothérapeutes, est complémentaire du champ d'exercice de l'ergothérapie, comme prévu à l'article 39.4 du Code des professions[9].

Les services du SAD sont offerts à une clientèle qui est dans l'incapacité de sortir de son domicile, sauf exception comme dans le cas d'usagers présentant une déficience physique. Dans les autres cas, les usagers sont transférés aux services externes répondant à leurs besoins. Les enjeux reliés au transport ne sont pas des critères recevables pour justifier l'implication d'un ergothérapeute du soutien à domicile.

Enfin, il est important de spécifier que certains motifs de référence sont exclus de l'offre de services du SAD et ce, même si l'usager est dans l'incapacité de sortir de son domicile : la thérapie de la main, l'évaluation de la capacité à conduire et l'évaluation pour l'obtention d'un véhicule adapté.

6.3. Les activités réservées aux ergothérapeutes et applicables dans leur travail au soutien à domicile[10]

- Procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette évaluation est requise en application d'une loi;
- Évaluer la fonction neuro-musculo-squelettique d'une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
- Prodiguer des traitements reliés aux plaies;
- Évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.

Il est important de préciser que l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle n'est pas permise au domicile de l'usager ni dans les résidences pour personnes âgées de catégorie « autonome » ou « semi-autonome »[11]. Dans ce contexte, l'ergothérapeute pratiquant au SAD décidera plutôt des mesures de remplacement, alternatives aux mesures de contrôle.

[8] Code de déontologie des ergothérapeutes C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes
[9] Code des professions, article 39.4 C-26 - Code des professions (gouv.qc.ca).
[10] Code des professions Article 37.1 C-26 - Code des professions (gouv.qc.ca).
[11] Protocole sur l'application des mesures de remplacement et sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle, p.31-32 http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Politiques__lois_et_reglements/Politiques/DSIEC/PRO_DSIEC-DSM_168_Mesures_controle.pdf

6.4. Principaux motifs de référence en ergothérapie

Au soutien à domicile, les interventions réalisées en ergothérapie au SAD ont été classifiées en cinq principaux motifs de référence :

- Enjeux fonctionnels et sécurité à domicile :
- Interventions reliées aux plaies;
- Soins palliatifs et fin de vie;
- Interventions reliées à la dysphagie;
- Barrières architecturales et programme d'adaptation du domicile (PAD)
- Aides à la mobilité (programme d'attribution des fauteuils roulants, ambulateurs, des triporteurs et des quadriporteurs)

Pour chacun de ces motifs, les standards de pratique en ergothérapie sont précisés sous forme de tableau et construits selon un épisode de services. Ceci est un guide pour l'ergothérapeute et en aucun moment il ne remplace le jugement clinique.

Un algorithme (annexe 1) a été conçu également à l'égard des autres professionnels travaillant au soutien à domicile afin de les aider à bien déterminer quand est-ce qu'il est requis de référer en ergothérapie et quelles sont les réflexions à avoir en amont.

6.4.1. Tableaux des interventions réalisées en ergothérapie au SAD en fonction des principaux motifs de référence

La liste des objectifs et des interventions présentée pour chaque motif de référence n'est pas exhaustive. Elle reflète, cependant, de façon générale, les objectifs et les interventions visés par ce motif.

Aussi, pour chaque motif de référence, la coordonnatrice clinique devra se référer aux critères de priorisation établis dans le document du ministère de la Santé et des Services sociaux (annexe 1).

Enfin, la collecte de données évaluatives est habituellement d'une durée approximative de 30 à 45 minutes et devrait se baser uniquement sur les documents pertinents à l'analyse du dossier. Elle pourrait être plus longue dans les dossiers d'évaluation fonctionnelle chez la clientèle avec trouble neurocognitif (TNC).

6.5. Enjeux fonctionnels et sécurité à domicile

Évaluation	▪ Une (1) à deux visites à domicile. ▪ Durée approximative : 60 à 90 minutes.
Objectifs visés	▪ Identifier, avec l'usager et ses proches, les risques à la sécurité qui pourraient compromettre le maintien à domicile ou la sécurité lors de la prestation de soins. ▪ Identifier les stratégies d'adaptation et de compensation des déficiences pour permettre à l'usager et ses proches d'accomplir leurs buts occupationnels. ▪ Sécuriser et optimiser les transferts, les déplacements et réduire le risque de chute et de blessures associées. Spécifique à la clientèle dont l'intervenant pivot est d'une autre direction clinique (DPDRP, DSM) ▪ Collaborer avec l'intervenant pivot de l'autre direction clinique, si applicable, dans l'élaboration des objectifs avec l'usager. Spécifique à la clientèle avec troubles neurocognitifs (TNC) ▪ Identifier l'impact des pertes cognitives sur les capacités fonctionnelles de l'usager au niveau des AVQ et AVD ainsi que la présence ou non d'enjeux de sécurité à domicile (ex. : risque d'intoxication alimentaire et médicamenteuse, d'incendie, d'errance, de chute, capacité d'appel à l'aide, etc.). ▪ Contribuer à l'évaluation interprofessionnelle de l'inaptitude, si requis (implication de la neuropsychologue en services gériatriques possible). Spécifique à la clientèle avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) ▪ Identifier et détailler les manifestations comportementales justifiant ou non des mesures de remplacement. ▪ Déterminer les facteurs sous-jacents possibles des comportements à risque : la personne, l'environnement physique et humain (dont les équipements et l'organisation du travail et des soins), l'occupation

	▪ Identifier et analyser la probabilité du risque et la gravité des conséquences pour l'usager en lien avec l'utilisation ou non de mesures de contrôle.[12] ▪ Favoriser la présence de comportements appropriés et sécuritaires en déterminant la modalité d'intervention la plus adaptée pour l'usager.
Modalités d'interventions	▪ Faire les essais d'aides techniques, l'entraînement et conclure sur les équipements recommandés. ▪ Informer l'usager et ses proches de l'ensemble des démarches pour se procurer leurs aides techniques et offrir du support à l'usager sans réseau qui nécessitent un accompagnement. ▪ Enseigner à l'usager et aux proches l'utilisation des aides techniques, les conséquences fonctionnelles liées à la maladie, les approches relationnelles, les techniques de soin, les principes de transfert. ▪ Effectuer les démonstrations PDSP et fournir la documentation écrite au besoin. ▪ Enseigner les principes de conservation d'énergie et stratégies de gestion de la douleur. ▪ Informer et orienter l'usager et ses proches vers les ressources et les programmes existants et accompagner ceux-ci au besoin : programmes communautaires, programme intégré d'équilibre dynamique (PIED), centre de jour, programme d'évaluation spécialisé de deuxième ligne (services d'aides techniques (SAT)), hôpitaux de jour. ▪ Compléter les démarches de financement au programme d'aides matérielles (AVQ-AVD) si admissible (voir tableau 6.5). ▪ Orienter en physiothérapie en présence d'un potentiel de réadaptation et d'amélioration des capacités. Spécifique à la clientèle avec SCPD ▪ Informer l'usager, ses proches et le personnel de soins et services, des causes possibles des comportements à risque, les risques associés à l'utilisation de mesures de contrôle et les bénéfices des mesures alternatives. ▪ Accompagner l'usager et ses proches soit dans la mise en place de stratégies favorisant un comportement approprié et sécuritaire, soit dans la démarche pour mettre en place les mesures de remplacement. ▪ Proposer et faire l'essai des mesures de remplacement et des mesures préventives en tenant compte des comportements à risque de l'usager. ▪ Évaluer l'efficacité des interventions proposées et recommander celles qui sont le plus appropriées pour l'usager, ses proches et le milieu de vie.
Suivis	▪ Suivi d'un maximum de 4 rencontres. ▪ Au-delà de 4 rencontres, une justification clinique est requise dans la note de suivi au dossier et une consultation avec la coordonnatrice clinique est demandée. ▪ Durée approximative des rencontres : 30 à 60 minutes.

[12] OEQ en ligne, Les mesures de contention : de la prévention à leur utilisation exceptionnelle

	Particularité pour la clientèle dont les interventions sont uniquement reliées à des SCPD ▪ Si une mesure de contrôle est utilisée par les proches de l'usager à son égard, à l'encontre des recommandations émises par l'ergothérapeute, les conséquences actuelles et potentielles doivent être expliquées et notées au dossier. Il est important d'en aviser également le gestionnaire de service. Spécifique à la clientèle DI-TSA-DP ▪ Informer l'intervenant pivot DI-TSA-DP, si applicable, des recommandations émises au dernier suivi afin qu'il puisse s'assurer de leur suivi.
Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ Durée maximale du suivi : 4 à 10 semaines. ▪ Une fois que la demande au programme ministériel (AVQ-AVD et autres) est complétée, l'épisode de services peut être fermé.

6.5.1. Précisions concernant les interventions de l'ergothérapeute SAD auprès de la clientèle DI-TSA-DP

L'ergothérapeute au SAD favorisera le maintien de l'usager dans son milieu de vie en recherchant des stratégies compensatoires aux incapacités attribuables à une déficience physique ou au vieillissement.

Les interventions ciblant les particularités sensorielles et la réduction des manifestations comportementales et des incapacités reliées à une déficience intellectuelle ou au trouble du spectre de l'autisme ne font pas partie de l'offre de services SAD.

Ce type de problématique devra être adressé aux services spécialisés de la direction des programmes en déficiences et de la réadaptation physique (DPDRP), qui détiennent l'expertise pour ce genre de situation. L'ergothérapeute au SAD agit dans un rôle de consultant pour les atteintes des activités fonctionnelles en lien avec des incapacités physiques attribuables à la déficience physique (DP) ou au vieillissement.

6.5.2. Précisions concernant les interventions de l'ergothérapeute SAD auprès de la clientèle avec incapacités cognitives

Les interventions suivantes ne relèvent pas de l'ergothérapeute au SAD :

- Tests de dépistage cognitif;
- Évaluation fonctionnelle pour établir un diagnostic;
- Évaluation fonctionnelle sans facteur de risque compromettant le maintien à domicile;
- Évaluation des capacités à conduire un véhicule;
- Évaluation des fonctions cognitives (activité réservée aux médecins et neuropsychologues).

6.6. Interventions reliées aux plaies

Évaluation	▪ Une (1) visite à domicile. ▪ Durée approximative : 60 à 90 minutes.
Objectifs visés	▪ Identifier les facteurs étiologiques et déterminer leur impact sur la plaie / risque de plaie, sur la douleur, le confort, et sur les occupations significatives / habitudes de vie (exemple d'outil d'évaluation : échelle de Braden[13]). ▪ Réduire les facteurs de risque et agir sur les causes pour la prévention et la guérison des plaies, la réduction de la douleur et l'inconfort. ▪ Favoriser la participation aux occupations significatives et aux saines habitudes de vie afin de : – Préserver l'autonomie à s'alimenter et s'hydrater pour une nutrition optimale ; – Optimiser la sécurité des transferts ; – Encourager la mobilité tout en considérant la friction et le cisaillement possibles au niveau de la plaie. ▪ Favoriser un positionnement optimal et confortable. ▪ Travailler en collaboration avec les soins infirmiers et le nutritionniste pour optimiser le traitement de la plaie.[14]
Modalités d'interventions	▪ Enseigner des stratégies de gestion de la douleur et de positionnement. ▪ Déterminer les interventions à mettre en place pour le positionnement couché et assis : – Établir un horaire de positionnement ; – Envisager et mettre en place des surfaces thérapeutiques au lit et au fauteuil (considérer la nature, le stade et la chronicité de la plaie, la nature de l'inconfort et de la douleur) ; – Considérer la réduction et le contrôle de la douleur dans le choix des recommandations ; – Tenir compte des dimensions occupationnelles dans le choix approprié des équipements. ▪ Faire l'essai et conclure sur les aides techniques, ressources pertinentes et demandes de subventions au besoin. ▪ Participer à l'organisation des services d'aide. ▪ Informer l'usager, ses proches et les ressources institutionnelles sur les facteurs à modifier et les stratégies et équipements suggérés.
Suivis	▪ Suivi d'un maximum 3 rencontres. ▪ Au-delà de 3 rencontres, une justification clinique est requise dans la note de suivi au dossier et une consultation avec la coordonnatrice clinique est demandée. ▪ Durée approximative des rencontres : 30 à 60 minutes.

[13] Échelle de braden, intranet CISSS Laurentides, https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/FP-CISSS-6032-_Evaluation_du_risque_de_plaies_de_pression__2017-01-12_.pdf
[14] OEQ en ligne, Une action concertée pour optimiser le traitement des plaies chroniques et complexes : cadre de collaboration interprofessionnelle pour les ergothérapeutes, les infirmières et les professionnels de la physiothérapie

Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ Durée maximale du suivi : 8 semaines. ▪ Précisions : L'épisode de services est fermé lorsque les facteurs de risques modifiables ont été identifiés et que des recommandations pour favoriser la prévention et la guérison des plaies de pression ont été effectuées (avec ou sans interventions associées, selon les besoins et la décision éclairée de l'usager d'appliquer ou non les recommandations). Dans ce contexte, il est possible de cesser le suivi en ergothérapie même si la plaie n'est pas guérie. Par contre, la fermeture de l'épisode pourrait être influencée par la présence d'une surface curative pour laquelle un suivi est demandé.

6.6.1. Précisions sur les interventions spécifiques de l'ergothérapeute vs celles de l'infirmière pour les soins de plaie

L'expertise de l'ergothérapeute et de l'infirmière dans le traitement de soins de plaie diffère principalement par leurs approches et leurs compétences spécifiques. Alors que l'infirmière se concentre sur la gestion clinique de la plaie, l'ergothérapeute intervient dans l'adaptation de l'environnement et des activités pour favoriser la guérison de la plaie et l'autonomie de la personne. Il est davantage impliqué dans les plaies/lésions de pression que les plaies reliées à un problème circulatoire.

Son implication peut s'avérer particulièrement bénéfique dans les deux situations suivantes :

- Clientèle ayant une détérioration de l'intégrité cutanée pour laquelle les interventions préventives en soins infirmiers se sont avérées insuffisantes;
- Clientèle ayant une plaie et pour laquelle la présence d'un handicap complexifie le processus de guérison (ex : incapacité à prendre la position debout ou relâcher la pression de façon autonome).

6.7. Interventions reliées aux soins palliatifs et fin de vie

Évaluation	▪ Une (1) à deux visites à domicile. ▪ Durée approximative : 60 à 90 minutes. ▪ Si l'usager en soins palliatifs manifeste l'intérêt d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, se référer aux documents de soutien disponible sur le site intranet du CISSS des Laurentides[15] et du gouvernement du Québec.[16] ▪ Questionner le projet de fin de vie de l'usager, si applicable.
Objectifs visés	▪ Identifier les difficultés / buts occupationnels avec l'usager et ses proches. ▪ Identifier les facteurs pouvant assurer ou compromettre le maintien à domicile en contexte de fin de vie selon le pronostic médical. ▪ Favoriser le maintien de l'autonomie de l'usager en fonction de ses choix et de ses priorités. ▪ Optimiser la qualité de vie et le confort de l'usager en considérant : – Les désirs et les priorités de l'usager (ex. : fin de vie à domicile) ; – La souffrance physique et psychologique ; – L'évolution prévisible ou non de la condition. ▪ Informer l'usager et ses proches des risques de sécurité identifiés.

[15] Soins palliatifs et soins de fin de vie: CISSS des Laurentides
[16] Aide médicale à mourir | Gouvernement du Québec

Modalités d'interventions	▪ Identifier les stratégies d'adaptation et les compensations des incapacités de l'usager. ▪ Faire les essais et conclure sur les aides techniques et les ressources pertinentes. ▪ Informer l'usager et ses proches de l'ensemble des démarches pour lui procurer les aides techniques. ▪ Enseigner les principes de mobilisation sécuritaire et de prévention des plaies. ▪ Participer à l'organisation des services d'aide à domicile.
Suivis	▪ 1 à 4 suivis pour la plupart des usagers même si le nombre peut s'avérer très variable selon la condition et l'évolution de l'usager.
Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ En soins palliatifs, la durée maximale d'un épisode de services est difficilement déterminable, car elle est intrinsèquement liée à l'évolution de l'état de santé de chaque usager. L'ergothérapeute pourra toutefois clore l'épisode de services lorsque les objectifs spécifiques à son rôle auront été atteints, et ce, même si l'état global de l'usager demeure précaire ou continue de se détériorer.

6.8. Interventions reliées à la dysphagie

Évaluation	▪ Une (1) visite à domicile. ▪ Durée approximative : 60 à 90 minutes. ▪ Évaluation de la déglutition et des habiletés fonctionnelles à l'égard de l'activité de s'alimenter.[17] ▪ Identifier l'impact des facteurs environnementaux, du positionnement ainsi que des dimensions physiques, cognitives et affectives lors de l'alimentation et de la déglutition.
Objectifs visés	▪ Réduire les risques d'aspiration et d'asphyxie ainsi que leurs conséquences. ▪ Favoriser la qualité de vie, la sécurité, le confort lors de l'alimentation. ▪ Favoriser l'autonomie de l'usager lors de l'alimentation. ▪ Favoriser un bon alignement des structures pour protéger les voies respiratoires lors de l'alimentation.
Modalités d'interventions	▪ Informer l'usager et ses proches des risques et des conséquences cliniques de la dysphagie. ▪ S'assurer de la compréhension des recommandations émises et expliquer à l'usager et ses proches les conséquences à ne pas mettre les recommandations en place. ▪ Enseigner à l'usager et à ses proches les techniques compensatoires à utiliser. ▪ Impliquer l'usager et ses proches dans les changements des textures et consistances recommandées, en collaboration avec la nutritionniste. ▪ Accompagner l'usager et ses proches dans les démarches pour l'obtention des aides techniques appropriées. ▪ Sensibiliser l'usager et ses proches relativement au positionnement à privilégier.
Suivis	▪ Suivi d'un maximum de 3 rencontres. ▪ Au-delà de 3 suivis, une justification clinique est requise dans la note de suivi au dossier et une consultation avec la coordonnatrice clinique est demandée. ▪ Durée approximative : 30 à 60 minutes.

[17] OEQ en ligne, La dysphagie et la pratique de l'ergothérapie | Ordre des ergothérapeutes du Québec

Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ Suivi d'une durée maximale de 6 semaines.

6.8.1. Précisions sur les interventions spécifiques de l'ergothérapeute vs celles de la nutritionniste

L'ergothérapeute et le nutritionniste jouent tous les deux un rôle auprès des usagers présentant une dysphagie mais leurs interventions se concentrent sur des aspects différents et complémentaires de la prise en charge, en fonction de leurs champs de pratique respectifs.

Au soutien à domicile, l'ergothérapeute intervient surtout sur le positionnement de l'usager, l'adaptation de son environnement et les techniques de compensation. Dans la majorité des cas, le nutritionniste évalue, en premier, les usagers dysphagiques. Il détermine les textures/consistances des aliments et des breuvages, établit l'équilibre nutritionnel et adapte le régime alimentaire en fonction des capacités de déglutition. Il travaille en collaboration avec l'ergothérapeute surtout dans les situations qui requièrent une adaptation de l'environnement et un positionnement plus complexe.

Par contre, dans un service où seul l'ergothérapeute est disponible pour procéder à l'évaluation de la dysphagie, il peut contribuer à déterminer les caractéristiques des aliments, notamment la texture des solides et la consistance des liquides afin de favoriser une alimentation sécuritaire, satisfaisante et propice à la santé et à l'autonomie optimales de la personne dysphagique[18]. Toutefois, étant donné que les modifications apportées aux textures et aux consistances peuvent avoir un impact significatif sur l'état nutritionnel, il est attendu que toute personne présentant une dysphagie bénéficie d'une évaluation nutritionnelle complète, afin de prévenir les conséquences nutritionnelles potentielles.

6.9. Barrières architecturales et programme d'adaptation du domicile (PAD)

La demande officielle provient de la société de l'habitation du Québec (SHQ)[19] :

- L'usager peut se procurer un formulaire d'inscription au PAD au CLSC, via l'intervenant pivot ou sur le site web[20] et fait parvenir ce formulaire à la SHQ ainsi que les autres documents requis.

La SHQ :

- Envoie l'inscription au guichet SAPA qui est responsable d'acheminer la demande au coordonnateur clinique en réadaptation du SAD. Un ergothérapeute du SAD sera alors attitré pour évaluation des besoins en réadaptation.
- Transmet un accusé de réception de la demande à l'usager et confirme son admissibilité au programme.

[18] OEQ en ligne, Contribution essentielle de l'ergothérapeute à l'égard de la recommandation de textures et consistances pour la clientèle dysphagique | Ordre des ergothérapeutes du Québec
[19] SHQ en ligne, Programme d'adaptation de domicile - Société d'habitation du Québec
[20] SHQ en ligne, Formulaire d'inscription au programme d'adaptation du domicile https://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/formulaires/amelioration_habitat_generaux/PAD/PAD-inscription-au-programme.pdf

La liste de priorisation est proposée par la SHQ mais gérée par la coordonnatrice du soutien à domicile. L'ergothérapeute en SAD peut communiquer avec l'inspecteur mandaté par la MRC/municipalité quand un dossier doit être priorisé.

L'épisode de services débute à la date de réception de la demande au guichet et se poursuit jusqu'à la complétion ou l'abandon des travaux.

Évaluation	▪ Une (1) à trois visites à domicile qui comprennent l'évaluation des habiletés fonctionnelles, les recommandations préliminaires d'adaptation ainsi que l'évaluation conjointe avec l'inspecteur pour déterminer les possibilités d'aménagement selon les buts/difficultés occupationnels déterminés avec l'usager. ▪ Durée approximative : 60 à 180 minutes pour chaque visite.
Objectifs visés	▪ Rendre le milieu de l'usager accessible et sécuritaire (accès au domicile et aux pièces admissibles). ▪ Optimiser l'autonomie aux AVQ/AVD. ▪ Sécuriser les déplacements, transferts et prestations des soins (incluant les employés de l'établissement, des services communautaires, ressources privées, etc.).
Modalités d'intervention	▪ Identifier les stratégies d'adaptation/compensatoires et les modifications environnementales possibles pour accomplir les buts occupationnels de l'usager avec ses proches en tenant compte des facteurs suivants : – La sécurité de l'usager et ses proches ; – L'acceptation de son état fonctionnel, le désir de changement, l'investissement en temps et les capacités financières ; – Le pronostic (évolutif vs stable) ; – Les risques et les bénéfices s'il n'y a pas de modification environnementale. ▪ Informer l'usager et ses proches de l'ensemble des démarches à faire et des étapes à respecter, des coûts possibles et des exclusions et de leurs responsabilités pour la réalisation du processus. ▪ Informer/accompagner l'usager et ses proches dans l'ensemble des démarches d'aménagement domiciliaire : – Assurer au besoin, une présence lors des visites de l'entrepreneur, avant, durant et après les travaux d'adaptation ; – Réaliser une visite pour s'assurer de la conformité des travaux. ▪ Informer/accompagner l'usager et ses proches sur les aides techniques et les ressources pertinentes : – Faire les essais et conclure sur les aides techniques et les ressources pertinentes ; – Enseigner, assurer l'entraînement à l'usager et aux proches pour l'utilisation sécuritaire des équipements et aides techniques ; – Faire la démonstration et remettre des dépliants et directives écrites selon le besoin.

© CISSS des Laurentides, juin 2025

Suivis	▪ Suivi d'un maximum de 5 rencontres. ▪ La durée du suivi varie considérant les délais possibles liés : – **À l'usager** (prise de décision, obtention des soumissions, réalisation des travaux, recherche de financement si coût excédant le PAD ou travaux non admissibles) ; – **Au propriétaire**, si l'usager est locataire (consentement aux travaux d'adaptation, aide financière reçue selon les critères du programme) ; – Au mandataire (rendez-vous, élaboration des plans et devis) ; – Aux partenaires impliqués.
Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ Durée maximale du suivi : 6 à 18 mois. ▪ Critères de fermeture spécifiques au PAD : – Lorsque les travaux sont terminés et conformes aux recommandations effectuées ; – Si l'usager déménage en cours de suivi ou est hébergé ; – Lorsque l'autonomie de l'usager change significativement en cours de processus rendant les travaux inutiles ou inadaptés à la nouvelle condition ; – Si l'usager décide de cesser volontairement le processus d'adaptation en ignorant le formulaire de la SHQ prévu à cet effet ; – S'il y a plus de 6 mois d'inactivité de la part de l'usager (aucune demande de soumission ou aucun suivi aux soumissions reçues).

6.9.1. Précisions concernant le programme PAD pour la clientèle DI-TSA-DP admissible

Les demandes d'adaptation du domicile en lien avec des troubles de comportements seuls, sans déficience physique, reliés à une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme ne relèvent pas de l'ergothérapeute au soutien à domicile. Ces usagers requièrent une expertise spécialisée qui est détenue par les ergothérapeutes de la DPDRP. L'ergothérapeute du SAD pourra, par contre, supporter au besoin dans les démarches reliées au PAD puisqu'il est davantage expert de ce programme que son collègue ergothérapeute de la DPDRP.

Dans les situations où l'adaptation est en lien avec des troubles de comportements ET des incapacités physiques, l'ergothérapeute du SAD et l'ergothérapeute DPDRP travailleront en collaboration, chacun dans son champ d'expertise, afin que les stratégies recommandées tiennent compte des particularités de la clientèle.

6.10. Programme d'aide à la mobilité (programme d'attribution des fauteuils roulants, ambulateurs, des triporteurs et des quadriporteurs)

Puisqu'une évaluation à domicile n'est pas requise pour les **marchettes RAMQ**, les usagers qui y sont éligibles seront automatiquement référés au centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) s'ils sont en mesure de sortir de leur domicile.

En ce qui concerne les **ambulateurs**, **triporteurs**, **quadriporteurs** et les **fauteuils roulants**, il est possible de consulter les guides ministériels en vigueur pour les programmes suivants :

- Programme d'attribution des triporteurs et des quadriporteurs ;[21]
- Programme d'attribution des ambulateurs ;[22]
- Programme d'aide de la RAMQ ;[23]
- Pour les fauteuils roulants RAMQ.[24.]

Concernant le programme d'attribution pour les fauteuils roulants, le service d'aides techniques (SAT) du centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) est responsable de l'évaluation et des recommandations en lien avec le fauteuil roulant ainsi que de son attribution.

Si le besoin d'un fauteuil roulant est pour un usager :

- Non desservi au SAD et sans autre besoin que l'attribution d'un fauteuil roulant ou le renouvellement de celui-ci : référence au SAT directement par le référent ;
- En épisode de services, actif en DI-TSA-DP, sans autre besoin que l'attribution d'un fauteuil roulant : service offert par l'intervenant pivot DI-TSA-DP pour référence au SAT ;
- En épisode de services, actif au SAD, non suivi en ergothérapie ou en physiothérapie : référence au SAT par l'intervenant SAD pivot au dossier. Si l'usager nécessite un prêt de fauteuil roulant en attendant son attribution de fauteuil roulant RAMQ, une référence en ergothérapie ou physiothérapie SAD pourrait être requise, selon le cas ;
- En épisode de services, actif au SAD en ergothérapie ou en physiothérapie: service offert par cet intervenant pour référence au SAT.

	Ambulateurs, triporteurs et quadriporteurs[25]
Évaluation	▪ Une (1) à 2 visites à domicile. ▪ Durée approximative des visites : 60 à 90 minutes. ▪ Vérifier l'admissibilité au programme. ▪ Expliquer les options de location et d'achats privés disponibles. ▪ En fonction du programme/formulaire à compléter : évaluation fonctionnelle et capacités à conduire ou à utiliser l'équipement dans l'environnement de façon sécuritaire, en situation réelle. ▪ Informer l'usager et ses proches de l'ensemble des démarches et de leurs responsabilités auprès de leur médecin ou tout autre organisme (assurances privées, solidarité sociale) et de leur compagnie d'assurance pour se procurer les aides à la mobilité.
Objectifs visés	▪ Identifier le type et/ou les caractéristiques de l'équipement répondant aux besoins de mobilité dans le but de favoriser l'autonomie et la sécurité de l'usager.

[21] Guide de gestion du Programme d'attribution des triporteurs et des quadriporteurs - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca).

[22] Programme d'attribution des ambulateurs : Guide de gestion. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000597/.

[23] Appareils suppléant à une déficience physique | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) (gouv.qc.ca)

[24] https://www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/formulaires/3841.pdf.

[25] Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024, page 84 et 86.

Modalités d'intervention	▪ Informer et accompagner l'usager et ses proches dans l'ensemble des démarches et de leurs responsabilités pour l'obtention de l'aide à la mobilité appropriée (médecin, compagnie d'assurance, centre de réadaptation, centre de l'emploi pour l'aide sociale) : – Soumettre le formulaire d'attribution à l'organisme payeur approprié; – Effectuer l'enseignement, l'entrainement et des mises en situation dans le milieu de vie de l'usager; – Réaliser une visite de conformité suite à l'attribution de l'équipement et compléter les formulaires requis.
Suivis	▪ Deux (2) à 4 suivis. ▪ Durée approximative : 45 à 60 minutes.
Durée de l'épisode de services	▪ Deux (2) à 6 mois ou plus selon les délais possibles liés à l'attribution par l'organisme payeur.
Fermeture de l'épisode/ fin du suivi	▪ Étant donné les délais d'attribution au SAT, la fermeture de l'épisode de services a lieu une fois que toutes les démarches ont été complétées et que l'usager est en attente d'attribution. L'épisode pourra être réouvert à la réception de l'équipement pour effectuer la visite de conformité.

6.11. Partenariat avec l'usager et ses proches : auto-soins, participation active et responsabilité partagée

6.11.1. Une approche centrée sur le partenariat

L'ergothérapeute au SAD agit dans une perspective de collaboration avec l'usager et ses proches, en tenant compte de leurs forces, valeurs, préférences et priorités. L'usager et ses proches sont reconnus comme partenaires actifs : leurs rôles ne se limitent pas à celui de bénéficiaires de services, ils sont également acteurs de leur propre plan d'intervention dans leur trajectoire de soins.

« *Le partenariat repose sur la reconnaissance de l'usager comme expert de son vécu et de sa condition, et du professionnel comme expert du soin. Ensemble, ils partagent les décisions et les responsabilités* »[26]

Cette approche favorise une meilleure adhésion aux recommandations et un maintien des acquis à long terme.[27] Elle contribue également à mieux définir les limites de l'épisode de services, en soutenant le transfert des compétences vers l'usager.

6.11.2. Concepts clés : auto-soins, participation, responsabilité partagée

L'intervention en ergothérapie au SAD vise à favoriser l'autonomisation de l'usager.

L'accompagnement offert doit permettre à la personne de :

[26] Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP). *Le modèle de Montréal du partenariat patient*. https://ceppp.ca

[27] Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). *Pratique centrée sur le client en ergothérapie*, 2010, p. 3–6

- Développer sa capacité à gérer ses occupations quotidiennes de manière autonome (auto-soins) ;
- Participer activement à l'établissement de ses objectifs et au suivi de son plan d'intervention ;
- Partager les responsabilités du processus avec les professionnels impliqués.

6.11.3. Alignement avec les orientations ministérielles

Le cadre sur l'approche intégrée de proximité pour les personnes aînées (2024) indique que les services doivent être élaborés « *avec, par et pour les personnes aînées* », misant sur la concertation, la vision et le leadership partenaire[28]

Le cadre actualisé de 2024 sur les proches aidants[29] souligne, quant à lui, leur rôle essentiel en les intégrant dans la planification des soins comme partenaires cliniques dotés de responsabilités claires.

6.12. Critères de fin d'intervention

La fin de l'épisode de services dépend du jugement clinique de l'intervenant et doit reposer sur des critères mesurables et objectivables. Voici une liste non exhaustive des critères qui pourraient justifier la fin d'intervention :

6.12.1. Atteinte des objectifs mesurables et réalistes

- L'usager a atteint l'autonomie fonctionnelle selon ses capacités et les risques au niveau de son intégrité physique sont minimisés
- **Capacité à sortir de son domicile :**
  - Les risques au niveau de son intégrité physique sont minimisés et il est capable de sortir de son domicile. Il est à noter que si l'usager présente encore des besoins pouvant faire l'objet d'intervention en ergothérapie, son dossier est alors transféré en services ambulatoires s'il répond à leurs critères d'admissibilité ;
  - L'absence de transport et les délais d'attente en clinique externe ne sont pas des critères justifiant la prolongation du suivi à domicile ;
  - L'usager pourra toujours être redirigé vers des ressources privées s'il le désire et si ses moyens financiers le lui permettent.
- **Non-respect du plan d'intervention :**
  - L'usager n'adhère pas au plan d'intervention malgré les différentes approches tentées ;
  - L'usager ne suit pas les recommandations émises par l'ergothérapeute ;
  - L'usager ne s'implique pas dans sa réadaptation ;
  - Le référant sera informé et d'autres solutions pourront être suggérées au besoin.

[28] MSSS. *Cadre de référence – Approche intégrée de proximité pour les personnes aînées*, juillet 2024, p. iv–v, publications.msss.gouv.qc.ca.
[29] MSSS. *Cadre de référence – Reconnaître les personnes proches aidantes comme partenaires pour mieux les soutenir*, novembre 2024, p. 1–3 publications.msss.gouv.qc.ca

- **Non disponibilité de l'usager :**
  - L'usager s'est montré indisponible[30] ou a refusé le service d'ergothérapie à trois reprises.

6.13. Tenue de dossier[31]

Différents documents sont à déposer au dossier et ils varient selon la nature de l'intervention. L'estimation du temps de rédaction nécessaire doit tenir compte de différents facteurs tels que :

- Le motif de la demande de service;
- La présence ou non d'un dossier documenté;
- Le type de rédaction (évaluation, note d'évolution, fin d'intervention);
- Les formulaires à compléter;
- Les types de démarches (ex. : programme AVQ-AVD, Programme d'aide à la mobilité, Programme d'adaptation du domicile (PAD), etc.).

Estimation du temps de rédaction en ergothérapie		
Document à compléter	**Temps de rédaction estimé**	**Délai visé de dépôt au dossier**
Rapport d'évaluation initiale (rédigé sur les formulaires prévus à cet effet).	60 à 90 minutes. Particularités rapports pour le PAD et contribuer à l'évaluation clinique de l'aptitude : 3 heures.	• Note d'évolution de prise en charge au plus tard 48 heures après l'activité. • Deux (2) jours ouvrables suivant la fin de l'évaluation.
Rapport d'évaluation spécifique ou formulaire pour démarche spécifique (aide à la mobilité, transport adapté, vignette de stationnement, demande activités de la vie quotidienne (AVQ) ou domestique (AVD), etc.)	30 minutes. Aide à la mobilité : 30 à 60 minutes .	• Lors de l'envoi au programme visé.
Note d'évolution	15 à 30 minutes.	• Au plus tard, 48 heures après l'activité. • Au plus tard 24 heures pour les cas urgents ou les situations graves/litigieuses.
Note de fermeture	30 minutes.	• 72 heures ouvrables.

Les ergothérapeutes doivent se conformer aux exigences de leur Ordre professionnel en termes de tenue de dossier, c'est-à-dire au « *Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de*

[30] Cadre normatif I-CLSC, Application de l'indisponibilité de l'usager lorsque l'établissement ne peut rejoindre l'usager
[31] CISSS Laurentides, Aide-mémoire sur la tenue de dossier. http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/SAPA/Aide_memoire_tenue_de_dossier.pdf

consultation et sur la cessation d'exercice des membres de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r.121.1) 2013 », ainsi qu'aux règles en vigueur au CISSS des Laurentides.

Afin de supporter les ergothérapeutes dans leur tenue de dossier, l'Ordre des ergothérapeutes (OEQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, a élaboré un aide-mémoire afin de les aider à être concis et pertinents dans leur rédaction[32].

Voici quelques-unes des recommandations clés, tirées de ce document :

- Garder le cap sur le fil conducteur des habitudes de vie problématiques;
- Ne pas « re-documenter » l'information déjà consignée au dossier usager et s'y référer en citant les sources;
- Abolir le verbatim et le descriptif chronologique; cibler et résumer les informations pertinentes;
- Se mettre dans la peau du lecteur pour rédiger et adopter une rédaction concise et structurée permettant un repérable rapide des informations importantes;
- Viser la pertinence, nul n'est obligé de compléter toutes les sections des gabarits/canevas.

[32] OEQ, Aide à la pertinence et à la concision de la tenue de dossier en soutien à domicile, janvier 2025 brochure ainsi que l'annexe qui en découle « Annexe- aide à la pertinence et à la concision de la tenue de dossier en soutien à domicile, 12114.pdf

Annexe 1 – Tableau des documents en découlant

Titre du document	Lien
Contrat d'engagement – Ergothérapie à domicile	À venir
Algorithme - Référence interne en ergothérapie au soutien à domicile (SAD)	Algorithme - Référence interne en ergothérapie au soutien à domicile (SAD)
Grille de priorisation multiclientèle en CLSC	Grille de priorisation multiclientèle en CLSC

© CISSS des Laurentides, juin 2025

Annexe 2 – Documents de référence

Agence de la santé et de santé et des services sociaux des Laurentides, Harmonisation de la gestion des listes d'attente I-CLSC – Orientations régionales.pdf.

Appareils suppléant à une déficience physique | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) (gouv.qc.ca)

Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). *Pratique centrée sur le client en ergothérapie*, 2010, p. 3–6

Cadre normatif I-CLSC, Application de l'indisponibilité de l'usager lorsque l'établissement ne peut rejoindre l'usager

Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP). *Le modèle de Montréal du partenariat patient*. https://ceppp.ca

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024.

CISSS de Laval, Guide des pratiques en soutien à domicile – Pour les directions SAPA et DI-TSA-DP – Partie 1 : volet organisationnel – Version préliminaire, 2021.

CISSS des Laurentides, Cadre de référence normes et standards de la pratique en ergothérapie et physiothérapie en milieu hospitalier Direction des services multidisciplinaires Octobre 2017 - Révisé juin 2018.

CISSS des Laurentides, capsule de formation à l'intention des professionnels de la santé sur l'application des mesures de remplacement et utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/situations-particulieres/mesures-de-controle/

CISSS des Laurentides, documentations cliniques en lien avec les symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/personnes-agees-sapa/symptomes-comportementaux-et-psychologiques-lies-a-la-demence-scpd/

CISSS des Laurentides, Politiques et procédures reliées aux mesures de remplacement et de ocontrôle Se référer aux politiques et procédures présentes reliées aux mesures de remplacement et de contrôle de la direction SAPA http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/situations-particulieres/mesures-de-controle/

CISSS des Laurentides, Soins palliatifs et soins de fin de vie: CISSS des Laurentides

CISSS Laurentides, Aide-mémoire sur la tenue de dossier. http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/SAPA/Aide_memoire_tenue_de_dossier.pdf.

Code de déontologie des ergothérapeutes C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Code des professions Article 39.4, C-26 - Code des professions (gouv.qc.ca).

Code des professions, article 37 o C-26 - Code des professions (gouv.qc.ca).

Échelle de Braden, intranet CISSS Laurentides, https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/FP-CISSS-6032-_Evaluation_du_risque_de_plaies_de_pression__2017-01-12_.pdf

Gouvernement du Québec, Aide médicale à mourir | Gouvernement du Québec

Guide de gestion du Programme d'attribution des triporteurs et des quadriporteurs - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca).

GUIDE DES STANDARDS DE PRATIQUE DE PREMIÈRE LIGNE AU SOUTIEN À DOMICILE, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille Capitale (document électronique), 2015.

INESS, Cadre d'élaboration des guides de pratiques dans le secteur des services sociaux, 2015.

Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024 page 28.

Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024, page 45 à 66.

Inspiré du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Cadre de référence Normes et standards de pratique des intervenants en ergothérapie et en physiothérapie, 2024, page 84 et 86

MSSS. *Cadre de référence – Approche intégrée de proximité pour les personnes aînées*, juillet 2024, p. iv–v, publications.msss.gouv.qc.ca.

MSSS. *Cadre de référence – Reconnaître les personnes proches aidantes comme partenaires pour mieux les soutenir*, novembre 2024, p. 1–3 publications.msss.gouv.qc.ca

OEQ en ligne, Contribution essentielle de l'ergothérapeute à l'égard de la recommandation de textures et consistances pour la clientèle dysphagique | Ordre des ergothérapeutes du Québec

OEQ en ligne, La dysphagie et la pratique de l'ergothérapie | Ordre des ergothérapeutes du Québec

OEQ en ligne, Les mesures de contention : de la prévention à leur utilisation exceptionnelle

OEQ en ligne, Référentiel de compétences lié à l'exercice de la profession d'ergothérapeute au Québec, Mars 2013, p.11 19675_Norme_OEQ.indd

OEQ en ligne, Une action concertée pour optimiser le traitement des plaies chroniques et complexes : cadre de collaboration interprofessionnelle pour les ergothérapeutes, les infirmières et les professionnels de la physiothérapie

OEQ, Aide à la pertinence et à la concision de la tenue de dossier en soutien à domicile, janvier 2025 brochure ainsi que l'annexe qui en découle « Annexe- aide à la pertinence et à la concision de la tenue de dossier en soutien à domicile, 12114.pdf

OEQ, en ligne, Participation du personnel non-ergotherapeute a la prestation des services d'ergotherapie - Lignes directrices

Orde professionnel de l'ergothérapie (OEQ) en ligne, OEQ : Ordre des ergothérapeutes du Québec

Programme d'attribution des ambulateurs : Guide de gestion
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000597/.

Protocole sur l'application des mesures de remplacement et sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle, p.31-32
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Mon_CISSS/Politiques__lois_et_reglements/Politiques/DSIEC/PRO_DSIEC-DSM_168_Mesures_controle.pdf

Régime d'assurance maladie du Québec (RAMQ), Attestation du besoin et d'une aide à la locomotion ou à la posture,
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/formulaires/3841.pdf.

SHQ en ligne, Formulaire d'inscription au programme d'adaptation du domicile
https://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/formulaires/amelioration_habitat_generaux/PAD/PAD-inscription-au-programme.pdf

SHQ en ligne, Programme d'adaptation de domicile - Société d'habitation du Québec